

ANAMNESE

Identificação: Boa tarde, meu nome é X tudo bem?

- | | |
|--|--|
| 1. Qual o seu nome COMPLETO? | 6. E você reside aonde agora? |
| 2. Quantos anos você tem? | 7. Qual a sua profissão? |
| 3. Qual a data de nascimento completa? | 8. O (a) Sr. (a) se autodeclara como de que cor? |
| 4. O (a) Sr. (a) é casado, solteiro, divorciado? | 9. E em relação ao gênero sexual? |
| 5. Onde você nasceu? | 10. Sua religião é? |

QP: Sr. (a), qual o motivo da consulta? (escreva a resposta entre “aspas”).

HMA (HDA): Investigação da queixa principal.

▪ A queixa é uma dor? DECÁLOGO!

1. Quando começou essa dor?
2. Onde dói? Aponta para mim, por favor.
3. E ela irradia para alguma área?
4. E como é essa sensação? É em aperto, em fincada, em queimação?
5. Se você fosse descrever a intensidade de 1 a 10, ficaria em quanto?
6. Quando a dor começa, ela começa logo muito forte ou vai piorando com o tempo?
7. Você lembra se algo causou essa dor? Se você estava fazendo algo no momento do início?
8. E tem algo que você faça que possa melhorar essa sensação?
9. Sente algum outro sintoma durante essas crises de dor? Algum sintoma associado?
10. Relacionar com funções orgânicas.

▪ A queixa é dispneia?

1. Quando começou?
2. O que desperta essa dificuldade de respirar? O fato de: fazer uma corrida, apenas caminhar ou tomar um banho? (perceber intensidade).
3. Você considera que ela dificulta os seus afazeres diários?
4. Ela piora pela manhã ou à noite?
5. É só dificuldade para respirar ou também sente uma “dorzinha” no peito?
6. O que você faz para melhorar a sensação? Usa algum medicamento?

▪ A queixa é tosse?

1. Quando começou essa tosse? (ver se é agudo ou crônico).
2. E qual a frequência da tosse? Dia inteiro?
3. Tem um horário que é pior?
4. Tem catarro quando você tosse? (seguida de expectoração?).
5. Se tiver catarro: que cor é o catarro, o Sr. (a) já reparou?
6. Está usando algum medicamento pra alívio da tosse? Qual?
7. Teve quadro de febre nesse período?
8. Alguma outra manifestação? Garganta, nariz?

ANAMNESE ESPECIAL – Passar por todos os sistemas do corpo de forma crânio-caudal (CABEÇA, TÓRAX, ABDOME, MEMBROS).

- **COONG:** Tem sentido dores de cabeça recentemente? Tontura? E a audição, está boa? Visão, enxergando bem? Respiração pelo nariz, tudo tranquilo? E a garganta, tem sentido alguma dor, desconforto, irritação?
- **Pescoço:** Mobilidade do pescoço está boa? Sem torcicolos, ou nódulos presentes da região?
- **TÓRAX:**
 - AR: tem sentido dor no peito? Falta de ar? Dificuldade para respirar? Tosse? Expectoração?
 - ACV: tem sentido tonturas? Hipotensão? Taquicardia?
- **ABDOME/PELVE:**
 - AD: Está alimentando bem, tem apetite? E a digestão, tudo certo? Como estão as fezes, reguladas, normais?
 - AGU: Como está a urina? Algum problema em segurar? Indo muitas vezes ao banheiro, ou tudo normal?
- **MEMBROS:** tem sentido a perna inchada? E presença de varizes, está ocorrendo? Mobilidade da perna, tudo ok?

HP (Pregressa): Fisiológica e Patológica

- **HPF**
 1. Como foi a gestação da sua mãe, tranquila? Você nasceu prematura ou no prazo certo (>37)?
 2. E o seu desenvolvimento? Falou e andou junto com os colegas de turma?
 3. Desenvolvimento da adolescência para a fase adulta, normal?
 4. PARA MULHERES: Quando foi sua 1ª menstruação? PARA MULHERES MAIS VELHAS: Quando foi sua última?
- **HPP**
 1. Você tem alguma doença crônica hoje? Tipo Diabetes, Hipertensão/“Pressão alta”?
 2. E na infância? Você teve alguma doença de passagem difícil?
 3. Alergia a medicamentos?
 4. Já foi internado?
 5. Passou por algum procedimento cirúrgico?
 6. Já fez hemotransfusão (transfusão de sangue)?
 7. E o cartão de vacinação, está completo?
 8. TENTE APROXIMAR DA QUEIXA.
Ex: Asma → pergunte se tem dermatite/rinite.

HF: até 03 gerações pelo ao menos (lembrar de perguntar também sobre o cônjuge).

- O (a) Sr. (a) tem os avós vivos? E eles são saudáveis ou possuem alguma doença?
- E quanto aos seus pais? Saudáveis?
- O (a) Sr. (a) possui irmãos? E eles como estão?
- E filhos, o (a) Sr. (a) tem? Sadios?

Obs: o ator pode não responder se tem ou não doença, mas pode falar que o parente X faz uso de medicamento. Nessa situação, pergunte o nome do medicamento.

HS: Ambiente domiciliar + Hábitos de vida.

- O (a) Sr. (a) fuma? Há quanto tempo?
- E bebidas alcóolicas, faz uso?
- Como é a alimentação, come de tudo? Verduras, legumes, frutas? Prefere uma comida muito salgada, ou um tempero mais leve? E óleo, usa muito na cozinha?
- Atividades físicas, faz com regularidade? Quantos dias na semana mais ou menos?
- Falando agora sobre a sua residência, como é o saneamento básico lá? Tem coleta de lixo? E água tratada, tem? E rede de esgoto, tem?
- Você tem algum animal de estimação? Quais? Quantos?

ECTOSCOPIA

Posição do paciente: lembrar que a posição varia em acordo com o que vai ser analisado.

Avaliação do estado geral	Atitude e decúbito no leito	Desenvolvimento físico	Estado de Hidratação
Nível de consciência	Atitude de pé ou postura	Desenvolvimento sexual	Exame dos linfonodos
Fala e linguagem	Biotipo	Tecido subcutâneo e Panículo Adiposo	Temperatura corporal
Marcha	Altura e outras medidas	Musculatura	Veias superficiais
Fácies	Peso	Estado de Nutrição	

Avaliação do Estado Geral

É o que aparenta o paciente, visto em sua totalidade. Se pergunte: o que a doença fez a esse paciente? Qual foi a repercussão geral?

Descrição: **BEG** (bom estado geral), **REG** (regular estado geral), **MEG** (mau estado geral).

Nível de Consciência

Percepção do mundo exterior, estado de vigília.

Está consciente? Está orientado no tempo e no espaço? Perguntar:

- Qual o seu nome?
- Que dia da semana é hoje? Nesse momento, está a noite ou de manhã?
- Onde você está?
- Quanto é 2+2?

Entre o estado de vigília e o estado comatoso, as alterações possíveis da consciência são:

Consciente?	Responde às perguntas normalmente.
Com sonolência?	É facilmente despertado, responde mais ou menos apropriadamente, mas logo volta a dormir.
Confuso mentalmente?	Perde a atenção; pensamento não é claro; Respostas lentas; Perdido no espaço e no tempo.
Obnubilado?	Nível de consciência pouco comprometido; ainda há sinal de alerta.
Em estado de torpor?	Alteração de consciência mais pronunciada; paciente ainda é capaz de ser despertado por estímulos mais fortes.
Em coma?	Paciente não se desperta nem com estímulos fortes; não há movimentos espontâneos.

Fala e Linguagem

Alterações que podem ser encontradas:

- **Disfonia ou Afonia:** Alteração do timbre da voz por problema no órgão fonador (voz rouca ou afônico).
- **Dislalia:** Alterações menores da fala, como a troca de letras. Uma forma especial é a disritmolalia (gagueira).
- **Disartria:** Alterações nos músculos da fonação, incoordenação cerebral (voz arrastada, escandida), por hipertonia do parkinsonismo (voz baixa, monótona e lenta) ou por perda do controle piramidal (paralisia pseudobulbar).
- **Disfasia:** distúrbio na elaboração cortical da fala (paciente não te entende e/ou não consegue se expressar).

Marcha

Solicitar ao paciente: Sr (a), caminhe, por favor, desse canto da sala até o outro canto. Você vai ir de olhos abertos e na volta venha com eles fechados. (de preferência: descalço).

Alteração de marcha pode significar distúrbios do aparelho locomotor e/ou do sistema nervoso.

Exemplos marchas TÍPICAS (isto é, típicas de alguma patologia):

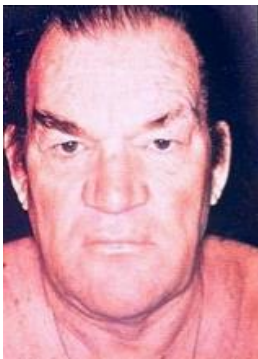
De pequenos passos (Petit Pass)	Diminuição do comprimento da passada, com deslocamento anterior do corpo. Tendência a quedas. Causa: Envelhecimento. Alzheimer.
Helicópode/Ceifante/Hemiplégica	Força-se o quadril para cima e para fora, jogando a coxa (movimento de hélice). Flexão de antebraço do lado do corpo comprometido. Causa: AVE.
Anserina ou De Pato	Mãos apoiadas na região lombar. Fase aérea circular. Hiperlordose lombar. Causa: Gestação. Distrofia muscular.
Parkinsoniana (é propulsiva)	Antes de iniciar o movimento: paciente se inclina e enrijece a cabeça anteriormente (dificuldade de iniciar movimento). Passos curtos. Tremedeira. Adução e flexão do antebraço. Causa: Síndrome de Parkinson.
Tabética	Base alargada. Paciente olhando para o chão. Marcha de soldado (flete as coxas em excesso + calcanhar batendo forte no chão). Causa: Neurosífilis.
Ebriante ou Cerebelar (do bêbado)	O paciente ziguezagueia, como um bêbado. Causa: lesão cerebelar.
Vestibular	O paciente caminha como se fosse empurrado para o lado ao tentar mover-se em linha reta (empurrado para o lado da lesão). Causa: lesão no vértice-cerebelo.
Escarvante	Quando o doente tem paralisia do movimento de flexão dorsal do pé, ao tentar caminhar, toca com a ponta do pé o solo e tropeça. Para evitar isso, levanta acentuadamente o membro inferior.
Espástica (em tesoura)	Se unilateral: perna esticada e braço acompanhando (hemiparesia espástica). Se bilateral: as duas pernas permanecem semifletidas >> pés se arrastando e pernas cruzando (em tesoura).
Claudicante	Ato de mancar. Causa: assimetria de membro, algia, DAOP.

Fácies

Trata-se do **conjunto de dados exibidos na face** do paciente (anatomia + fisionomia + expressão).

Exemplos de fácies TÍPICAS, isto é, típicas de alguma patologia:

Hipocrática (desnutridos)	Olhos fundos, parados e inexpressivos. Nariz afilado. Lábios delgados (podem estar um pouco cianóticos). Batimento de aleta nasal. Suor facial. Palidez cutânea. 
Renal	Edema bilateral bípálpebral + palidez cutânea. 

Leonina (típica da Hanseníase)	Pele espessa, nariz e lábios espessos, presença de muitos lepromas, ausência de supercílios, nódulos deformando a face. 
Adenoideana	Nariz pequeno e afilado e a boca sempre entreaberta. 
Parkinsoniana	Cabeça inclinada anteriormente e fixa. Expressão de espanto.
Basedowiana	Exoftalmia + rosto magro. Pode haver bócio. Expressão de espanto e de ansiedade. Comum no HIPERTireoidismo. 
Mixedematosa	Rosto redondo, nariz e lábios grossos. Cabelos secos e sem brilho. Expressão de desânimo. Comum no HIPOtireoidismo. 
Acromegálica	Saliência das arcadas supraorbitárias, proeminência das maçãs do rosto e maior desenvolvimento do maxilar inferior. Aumento do tamanho do nariz, lábios e orelhas. Olhos parecem pequenos. 

Paralisia Facial	Paralisia de uma metade da face. 
Cushingoide ou Lua Cheia	Síndrome de Cushing. Rosto redondo e com acne. 
Mongolóide	Fenda palpebral (prega cutânea no epicanto = olhos oblíquos; tipo de os de chineses). Rosto redondo, boca quase sempre entreaberta. 
Miastênica	Ptose palpebral bilateral que obriga o paciente a franzir a testa e levantar a cabeça. Ocorre na miastenia gravis (e em outras doenças que comprometem os músculos da pálpebra superior). 

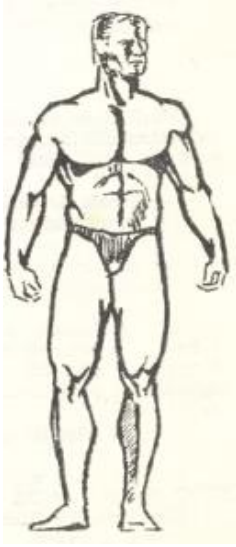
No OSCE:

- Tipo de fâcie: TÍPICA (anormal) OU ATÍPICA (normal).
- Nome da fâcie.
- Descrição da fâcie: fale as características.

Atitude e Decúbito no Leito

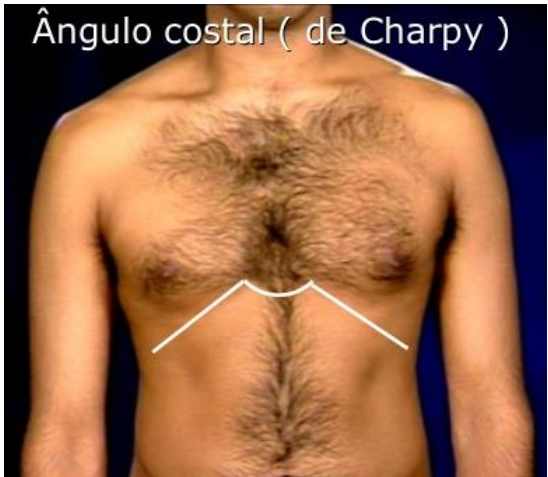
Atitude de pé ou Postura

Biotipo

Longilíneo	Normolíneo	Brevilíneo
▪ Pescoço longo e delgado. ▪ Tórax afastado e chato. ▪ Membros alongados com predomínio sobre o tronco. ▪ Musculatura delgada e panículo adiposo pouco desenvolvido. ▪ Tendência para estatura elevada. ▪ Ângulo de Charpy = < 90°.	▪ Equilíbrio entre os membros e o tronco. ▪ Desenvolvimento harmônico da musculatura e do panículo adiposo. ▪ Ângulo de Charpy = 90°.	▪ Pescoço curto e grosso. ▪ Tórax largo e volumoso. ▪ Membros curtos em relação ao tronco. ▪ Musculatura desenvolvida e panículo adiposo espesso. ▪ Tendência à baixa estatura. ▪ Ângulo de Charpy = > 90°.
		

No OSCE:

- 1. Cumprimente o ator + “considerar mãos higienizadas”.
- 2. Peça para que retire a blusa e fique de Pé: meça o ângulo de Charpy e externe o biotipo encontrado.



Altura, Peso e outras medidas

Entre na sala, cumprimente o ator, se apresente, pergunte o nome dele.

Diga: “considerar mãos devidamente higienizadas”.

Altura:

- Na criança, recomenda-se medir a altura na posição deitada, utilizando-se fita métrica ou régua graduada.
- Na criança maior e no adulto capaz de ficar em ortostatismo: medição em pé com fita métrica ou estadiômetro.

Peso:

Aproxima-se do número de centímetros que excede de um metro de altura e se expressa em Kg.

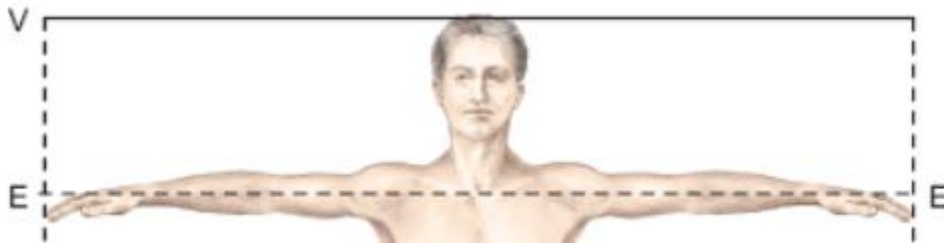
- Por exemplo: tem 1,82 de altura? Então devia ter aproximadamente 82kg.
- Obs: sexo feminino: subtrair 5% do valor encontrado.

Peso máximo normal: 10% ao peso ideal.

Peso mínimo normal: 10% do peso ideal.

Envergadura:

Para a envergadura, mede-se toda a extensão de uma ponta a outra da falange distal. A medida da envergadura corresponde à altura real.



IMC – Índice de Massa Corporal:

$$\text{IMC} = \text{Peso atual (kg)} / \text{Altura}^2 \text{ (m)}$$

Tabela IMC

- Baixo peso: < 20
- Peso normal: 20 – 25
- Sobrepeso: 25 – 30
- Obesidade: 30 – 40
- Obesidade grave: > 40

Circunferências Abdominal e da Cintura:

Abdominal:

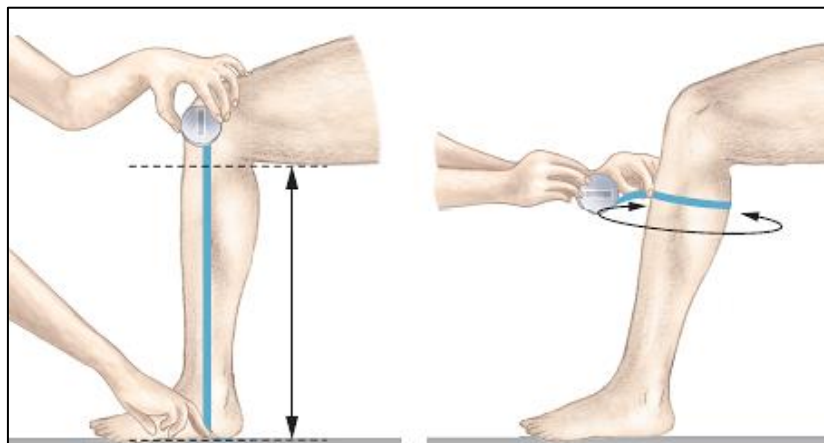


Da cintura: fita métrica entre ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca.



Circunferência da panturrilha: Importante para acompanhar o estado nutricional.

Deve ser feita com o indivíduo sentado, com os pés aproximadamente a 20 cm do corpo, joelho em ângulo de 90°. **Considera-se a medida mais larga da panturrilha da perna esquerda.**



Desenvolvimento físico

Desenvolvimento Sexual

Tecido Subcutâneo e Panículo Adiposo

Inspeção + Palpação.

Inspeção: processo inflamatório? Celulite? Lipomas? Fibromas? Cistos?

Palpação:

- 1° Polegar + indicador = pinçar a prega cutânea.
- 2° Palpar com polpas digitais e mãos espalmadas a área.

Exame normal: tecido subcutâneo íntegro sem presença de alterações à palpação e panículo adiposo [pouco desenvolvido OU razoavelmente desenvolvido OU muito desenvolvido].

Musculatura

Inspeção + Palpação.

1. Boa Tarde, qual o seu nome? Meu nome é X e vou examinar sua musculatura.
2. Posicione o paciente sentado na maca ou de pé.

Inspeção: OLHE ATENTAMENTE a superfície corporal com o paciente em repouso, observando o relevo das massas musculares.

- Massa normodistribuída?

Palpação:

- Agora vou palpar os músculos, primeiro sem contrair.

- Agora, faça a contração, por favor.

- Com as polpas digitais colocadas em forma de pinça e com o polegar em oponência aos demais dedos da mão apalpe os músculos do paciente. (no OSCE: MMSS, se possível MMII).
- Troficidade (quantidade de massa muscular): normotroficidade? Hipotroficidade? Hipertroficidade?
- Tonicidade (corresponde ao tônus): normotonicidade? Hipertonicidade? Hipotonicidade?



Estado de Nutrição

O que deve ser avaliado:

- Peso.
- Desenvolvimento físico.
- Musculatura.
- Estado geral.
- Panículo adiposo.
- Pele, pelos e olhos.

Como se portar no OSCE:

1. Cumprimente o paciente + mãos higienizadas.
2. Qual o estado geral do paciente?
3. Peça ao paciente para se levantar: massa normodistribuída?

4. Em seguida comece a palpar os músculos do braço do paciente: normotrófico?
5. Enquanto palpa pergunta: O (a) Sr (a) tem se alimentado bem? Perdeu quantidade importante de peso recentemente?
6. Peça para que o paciente levante a blusa até a altura do peito:
 - a. Presença de obesidade central?
 - b. Palpe o panículo adiposo (polegar e indicador: pinça-se uma prega da pele): panículo adiposo espesso? Pouco desenvolvido? Razoavelmente desenvolvido?
7. Pergunte peso e altura: o peso tem que representar aproximadamente o número de centímetros da altura (nas mulheres é um pouco menos – -5%) → paciente provavelmente está dentro do IMC correto utilizando dos dados altura e peso, embora não disponho da ferramenta necessária para o cálculo correto.
8. Analise a pele: normocorada e hidratada.
9. Analise mucosa do olho: normocorada e úmida.
10. Analise cabelos: cabelos com brilho normal.

Estado de Hidratação

O que deve ser avaliado:

- Sede.
- Queda abrupta de peso.
- Pele seca: ↓ turgor, ↓ elasticidade.
- Mucosas secas.
- Olhos afundados (enolftamia) e hipotônicos.
- Fontanelas deprimidas (crianças).
- Estado geral comprometido.
- Excitação psíquica ou abatimento.
- Oligúria.

Como se portar no OSCE:

1. “Considerar mão higienizadas” + Cumprimente o paciente: Olá Sr (a) X, meu nome é Y e eu vou analisar sua hidratação.
2. Você tem sentido muita sede ou perdeu quantidade importante de peso recentemente?
3. Ingere bastante água diariamente?
4. E a urina? Normal ou diminuída?
5. Vou examinar sua pele e seus olhos agora:
 - a. Pele: turgor preservado? Pele hidratada?
 - b. Mucosa dos olhos: normocorada e úmida? Ausência de enoftalmia?
6. Estado geral do paciente: BEG?

Exame dos Linfonodos

Temperatura Corporal

A mensuração da temperatura corporal pode apresentar variações dependendo do local em que é registrada: **axilar, oral, retal, timpânico, arterial pulmonar, esofágico, nasofaringiano e vesical.**

O local tradicional é o **oco axilar**. Para utilização correta é necessária a higiene da axila e do termômetro, evitando-se umidade no local.

Valores normais

- Temperatura axilar: 35,5 a 37°C, com média de 36 a 36,5°C.
- Temperatura bucal: 36 a 37,4°C.
- Temperatura retal: 36 a 37,5°C, ou seja, 0,5°C maior que a axilar.

FEBRE?

- Febre leve ou febrícula: até 37,5°C
- Febre moderada: de 37,6° a 38,5°C
- Febre alta ou elevada: acima de 38,6°C.

Hipertermia?

Hipotermia?

Veias Superficiais

1. Diga “considerar mãos devidamente higienizadas”.
2. Se apresente e pergunte o nome do ator, cumprimentando-o.
3. “Vou analisar suas veias das pernas, sente-se à MACA”.
4. Observe o membro: ausência de vermelhidão? Varizes? Flebites?
5. Palpe o membro: ausência de edema?
6. Sinal de cacifo negativo?

Obs: ainda nos MMII, pode-se avaliar os sinais de TVP, que são:

- Sinal de Bancroft: dor à palpação no membro afetado.
- Sinal de Homans: dor à flexão no membro afetado.
- Sinal da Bandeira: menor mobilidade no membro afetado.
- As pernas podem estar: vermelhas, quentes (sinais inflamatórios).

Edema

1. Quando começou a perceber o edema?
2. Tem sentido que houve piora do edema?

+ Observar:

- **Localização?** Local ou generalizado?
- **Intensidade?** Com a polpa digital do indicador, faz-se uma compressão de encontro a uma estrutura rígida subjacente à área do edema Retira-se o dedo Depressão? = SINAL DE CACIFO POSITIVO (+/++/+++/++++).
- **Consistência?** Mole ou endurecido (este é mais antigo)?
- **Elasticidade?** Elástico OU Inelástico (quando a pele demora a retornar)?
- **Temperatura da pele circundante?** Normal, quente (inflamação), frio (irrigação comprometida)?
- **Sensibilidade?** Doloroso (indica processo inflamatório) ou Indolor?

SEMIOLOGIA APARELHO CARDIOVASCULAR

Inspeção

Pesquisa de abaulamento: Com o paciente sentado e com o tórax desnudo observar abaulamentos e retrações do tórax.

Ictus cordis: Com o paciente deitado observar por cima o tórax e depois transversalmente a região do foco mitral.

- Está visível?

Análise de batimentos ou movimentos visíveis: Com o paciente também deitado. Posicionar-se à direita do paciente e observar de maneira transversal as pulsações ao nível do epigástrio (aorta abdominal) e da fúrcula esternal (arco da aorta).

Palpação

Pesquisa de abaulamento: Com o paciente sentado e com o tórax desnudo, palpar o tórax e ver presença de abaulamentos e/ou retrações.

Ictus cordis: Corresponde ao foco mitral.

Localização normal (varia com o biotipo):

- Normolíneos: 5° EIC linha hemiclavicular esquerda.
- Brevilíneos: desloca-se para fora e para cima.
- Longilíneos: 6° EIC 1 ou 2cm para dentro da linha hemiclavicular esquerda.

Extensão: DEVE < ou = 2 polpas digitais.

- Maior que isso e/ou deslocado de posição normal? Hipertrofia de VE.

Mobilidade: palpa-se em decúbito dorsal, e depois se palpa em decúbito lateral (D e E). A diferença de localidade deve estar entre 1 e 2cm.

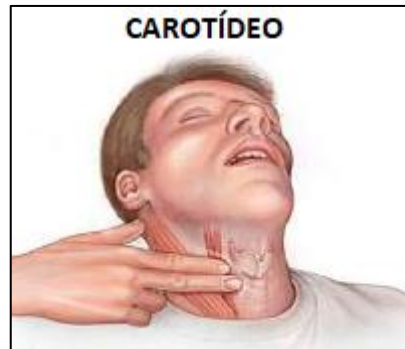
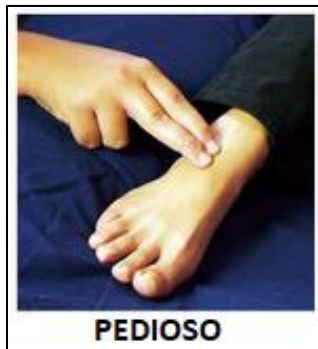
Intensidade: pouco propulsivo? Muito propulsivo? Normointenso.

- Poupa propulsão? ICC, MCD.
- Muita propulsão? HAS, estenose aórtica, hipertireoidismo.

Ritmo e frequência: melhor avaliado na ausculta.



Pulsos periféricos:

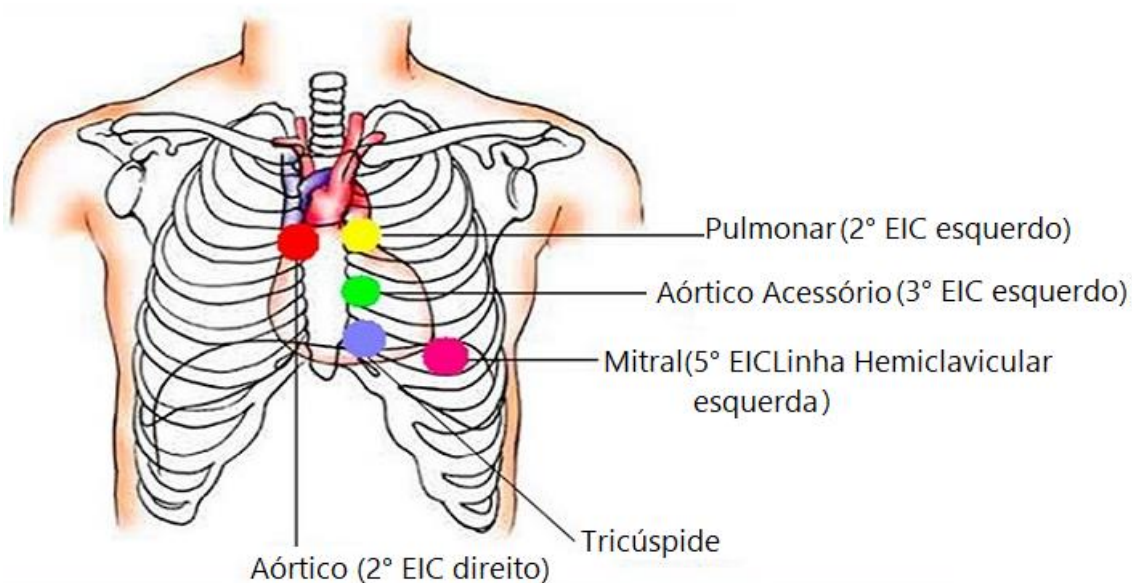


Obs:

- **Análise de movimentos ou batimentos visíveis ou palpáveis** (na inspeção ou na palpação): pulsação epigástrica (pode ser na aorta abdominal) e pulsação na fúrcula esternal (pode ser no arco da aorta).
- **Frêmito CV:** quando o sopro é sentido por vibração no tórax (> ou = +4).

Ausculta

Ausculta dos focos + Contagem da FC.



Semilunares fechando: início da diástole = TÁ (b2).

Atrioventriculares fechando: início da sístole = TUM (b1).

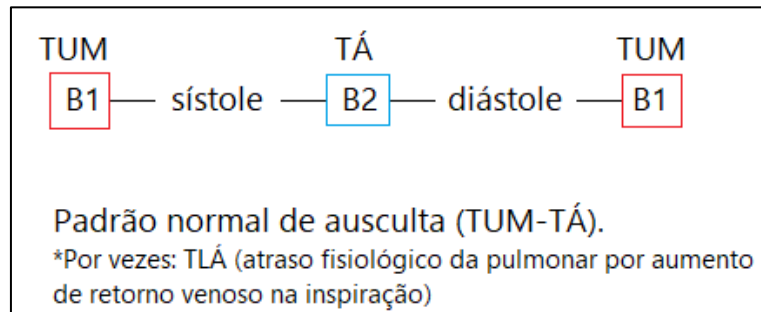
No OSCE: Ouvir atentamente o comando. Qual foco foi pedido? Não houve indicação de foco? Ouça todo o precórdio!

COMO OUVIR CADA FOCO MELHOR?

- Pulmonar e Aórtico: INCLINE O PACIENTE PARA FRENTE!
- Mitral: FAÇA DECÚBITO LATERAL ESQUERDO.
- Tricúspide: Pedir para inspirar.

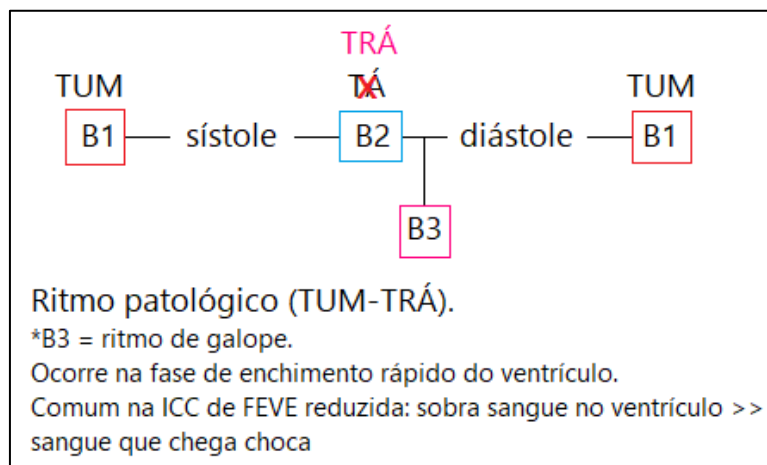
Padrão normal de ausculta:

O achado é: RITMO CARDÍACO REGULAR EM DOIS TEMPOS, BULHAS CARDÍACAS NORMOFONÉTICAS.



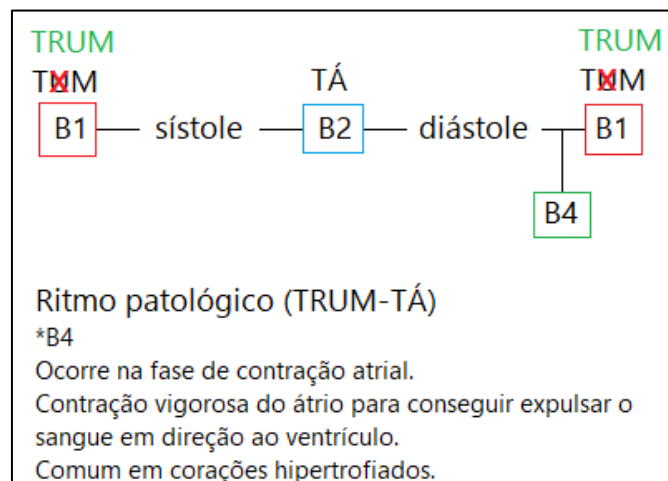
Presença de B3 e de B4:

O achado é: RITMO CARDÍACO REGULAR EM TRÊS TEMPOS, COM PRESENÇA DE B3.



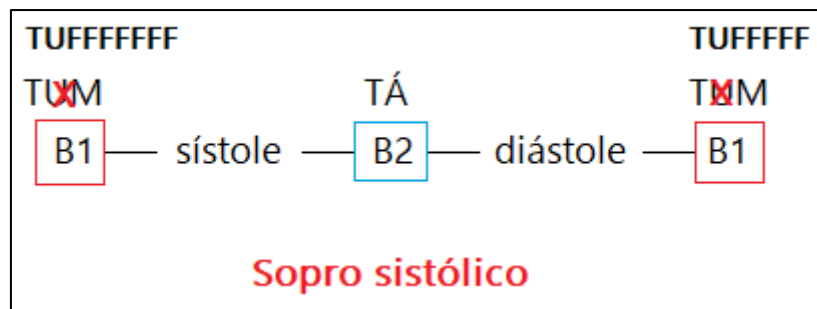
Os sons TUM e TRÁ são mais próximos.

O achado é: RITMO CARDÍACO REGULAR EM TRÊS TEMPOS, COM PRESENÇA DE B4.

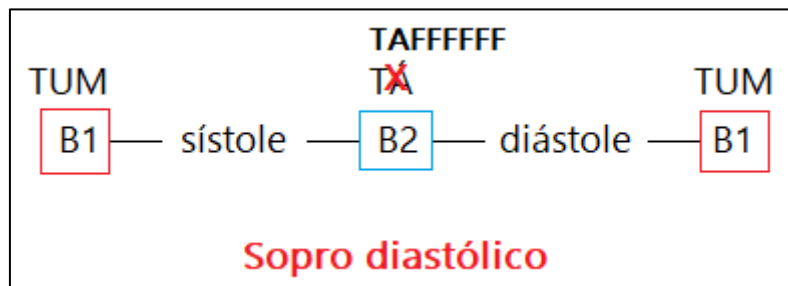


Presença de sopros:

O achado é: RITMO CARDÍACO REGULAR EM DOIS TEMPOS, COM PRESENÇA DE SOPRO SISTÓLICO.



O achado é: RITMO CARDÍACO REGULAR EM DOIS TEMPOS, COM PRESENÇA DE SOPRO DIASTÓLICO.



Presença de arritmias:

O achado é: RITMO CARDÍACO IRREGULAR.

Medida da PA

Ator?

1. “Considerar mãos devidamente higienizadas”.
2. Cumprimente.
3. Se apresente: Meu nome é X, qual o seu nome?
4. Pesquise o paciente quanto a situações que possam alterar a medida: O (a) Sr (a) fumou, fez exercícios, bebeu bebidas alcóolicas ou café nos últimos 30 minutos? E sua bexiga... Está cheia?
5. Fique ao lado DIREITO do paciente.
6. Ajeite o paciente: pernas descruzadas, antebraço ao nível do precórdio.
7. Faça método palpatório e método auscultatório.

Boneco?

1. Considerar mãos devidamente higienizadas e que o paciente não bebeu, fumou, tomou café, fez exercícios ou está com a bexiga cheia.
2. Posicionar-se ao lado DIREITO do braço.
3. Prosseguir técnica.

Análises sobre SISTEMA HEMOLINFOPOIÉTICO

Hemograma & Anemias

Exemplos de Hemogramas e o que deve ser analisado:

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	7,5	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	33	38 A 53
VCM	72	80 A 100
CHCM	29	30 A 36
RDW	16	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	4.500	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	55	45 A 65%
BASTOES	0	0 A 3%
EOSINOFILOS	4	0 A 5%
MONOCITOS	3	0 A 3%
BASOFILOS	4	0 A 5%
LINFOCITOS	34	20 A 45%
PLAQUETAS	180.000	150.000 A 450.000

Hb < 11 = ANEMIA.

↓ Hematócrito (< 38): hemodiluído (menor quantidade de hemácias).

↓ VCM: hemácias pequenas = microcíticas.

↓ CHCM: hemácias claras (menos Hb) = hipocrômicas.

↑ RDW: evidencia Anisocitose (hemácias de tamanhos diferentes).

Leucócitos normais e Plaquetas normais.

Anemia microcítica e hipocrômica com Anisocitose = provável causa é deficiência de ferro.

Obs: Talassemia e anemias sideroblásticas também são microcíticas e hipocrômicas.

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	13	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	45	38 A 53
VCM	88	80 A 100
CHCM	34	30 A 36
RDW	13	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	14.000	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	65	45 A 65%
BASTOES	5	0 A 3%
EOSINOFILOS	2	0 A 5%
MONOCITOS	2	0 A 3%
BASOFILOS	1	0 A 5%
LINFOCITOS	35	20 A 45%
PLAQUETAS	250.000	150000 A 450000

Hb normal (> 12): não se trata de anemia.

Hematócrito normal: concentração normal do plasma sanguíneo.

VCM: normal = normocítico.

CHCM: normal = normocrômico

RDW: normal = ausência de Anisocitose.

↑ Leucócitos: LEUCOCITOSE.

Eosinófilos, monócitos, basófilos e linfócitos com porcentagem normal = leucocitose proporcional.

↑ Bastões: desvio à esquerda.

Segmentados em alto número, mas ainda dentro de valor normal.

Plaquetas NORMAIS.

Leucocitose “discreta” e à custa de bastões (desvio a esquerda): Infecção bacteriana?

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	11,2	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	37	38 A 53
VCM	108	80 A 100
CHCM	35	30 A 36
RDW	14	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	4.600	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	50	45 A 65%
BASTÕES	0	0 A 3%
EOSINÓFILOS	4	0 A 5%
MONOCITOS	3	0 A 3%
BASÓFILOS	2	0 A 5%
LINFÓCITOS	41	20 A 45%
PLAQUETAS	140.000	150.000 A 450.000

↓ Hb = anemia.

Hematócrito: hemodiluído (baixa quantidade de hemácias).

↑ VCM: tamanho aumentado da hemácia = macrocítica.

CHCM: cor normal da hemácia = normocrômica.

RDW: normal = ausência de Anisocitose.

Leucócitos normais.

↓ Plaquetas: Discreta plaquetopenia (trombocitopenia).

Anemia macrocítica e normocrômica: anemia megaloblástica? Por deficiência de B12 ou de B9?

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	10,7	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	35	38 A 53
VCM	88	80 A 100
CHCM	35	30 A 36
RDW	12	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	3.800	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	55	45 A 65%
BASTÕES	0	0 A 3%
EOSINÓFILOS	5	0 A 5%
MONOCITOS	3	0 A 3%
BASÓFILOS	2	0 A 5%
LINFÓCITOS	35	20 A 45%
PLAQUETAS	130.000	150.000 A 450.000

↓ Hb = anemia.

↓ Hematócrito: hemodiluído (menor nº de hemácias no plasma sanguíneo).

VCM: normal = normocítico.

CHCM: normal = normocrômico.

RDW: normal = ausência de Anisocitose.

↓ Leucócitos: LEUCOPENIA (proporcional).

↓ Plaquetas: plaquetopenia/trombocitopenia.

Anemia normocítica e normocrômica: doença crônica?

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	14,5	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	48	38 A 53
VCM	90	80 A 100
CHCM	35	30 A 36
RDW	14	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	3.800	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	45	45 A 65%
BASTOES	0	0 A 3%
EOSINÓFILOS	0	0 A 5%
MONOCITOS	1	0 A 3%
BASÓFILOS	1	0 A 5%
LINFÓCITOS	53%	20 A 45%
PLAQUETAS	300.000	150.000 A 450.000

Hb: normal = ausência de anemia.

Hematócrito: normal = concentração normal no plasma sanguíneo.

VCM: células de tamanho normal = normocítico.

CHCM: células de cor normal = normocrômico.

RDW: normal = ausência de Anisocitose.

↓ Leucócitos: LEUCOPENIA, mas com LINFOCITOSE (↑ Linfócitos) = *infecção viral?*

Plaquetas normais.

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	14	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	50	38 A 53
VCM	82	80 A 100
CHCM	36	30 A 36
RDW	14	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	3.500	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	45	45 A 65%
BASTOES	0	0 A 3%
EOSINÓFILOS	5	0 A 5%
MONOCITOS	3	0 A 3%
BASÓFILOS	2	0 A 5%
LINFÓCITOS	45	20 A 45%
PLAQUETAS	306.000	150.000 A 450.000

Hb: valor normal = ausência de anemia.

Hematócrito: valor normal = concentração normal no plasma sanguíneo.

VCM: normal (células normocíticas).

CHCM: normal (células normocrômicas).

RDW: normal (ausência de Anisocitose).

↓ Leucócitos: LEUCOPENIA proporcional = *Infecção viral?*

Nº de plaquetas normais.

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	6,9	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	37	38 A 53
VCM	78	80 A 100
CHCM	28	30 A 36
RDW	12	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	3.500	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	40	45 A 65%
BASTOES	0	0 A 3%
EOSINÓFILOS	1	0 A 5%
MONOCITOS	1	0 A 3%
BASÓFILOS	3	0 A 5%
LINFÓCITOS	55	20 A 45%
PLAQUETAS	75.000	150.000 A 450.000

↓↓↓ Hb: forte anemia.

↓ Hematócrito: hemodiluído (concentração diminuída no plasma sanguíneo).

↓ VCM: células microcíticas.

↓ CHCM: células hipocrômicas.

RDW: normal = ausência de Anisocitose.

↓ Leucócitos: LEUCOPENIA: ↓ Segmentados e ↑ Linfócitos.

↓↓↓ Plaquetas: importante plaquetopenia/trombocitopenia.

Anemia microcítica e hipocrômica: Deficiência de ferro?

Plaquetopenia + Leucopenia + Linfocitose = Infecção viral?

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	6,5	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	33	38 A 53
VCM	81	80 A 100
CHCM	31	30 A 36
RDW	12	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	4.200	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	50	45 A 65%
BASTOES	0	0 A 3%
EOSINÓFILOS	2	0 A 5%
MONOCITOS	2	0 A 3%
BASÓFILOS	5	0 A 5%
LINFÓCITOS	41	20 A 45%
PLAQUETAS	145.000	150.000 A 450.000

↓↓↓ Hb: forte anemia.

↓ Hematócrito: hemodiluído (concentração diminuída no plasma).

VCM: normal (células normocíticas).

CHCM: normal (células normocrômicas).

RDW: normal (ausência de Anisocitose).

Leucócitos: valor normal.

↓ Plaquetas: Discreta plaquetopenia.

Anemia normocítica e normocrômica: por Doença crônica.

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	11,2	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	38	38 A 53
VCM	76	80 A 100
CHCM	30	30 A 36
RDW	16	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	4.500	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	45	45 A 65%
BASTOES	0	0 A 3%
EOSINÓFILOS	13	0 A 5%
MONOCITOS	2	0 A 3%
BASÓFILOS	5	0 A 5%
LINFÓCITOS	35	20 A 45%
PLAQUETAS	40.000	150.000 A 450.000

↓ Hb: anemia.

Hematócrito: normal (concentração normal no plasma).

↓ VCM: diminuído (células microcíticas).

CHCM: normal (células normocrômicas).

Anemia microcítica: deficiência de ferro?

↑ RDW: presença de Anisocitose.

Leucócitos: valor normal, mas EOSINOFILIA (↑ eosinófilos) = reação alérgica? Parasitose?

↓ Plaquetas: importante plaquetopenia/trombocitopenia.

ITEM AVALIADO	RESULTADOS	REFERÊNCIAS
HEMOGLOBINA	12,5	MAIOR QUE 12
HEMATOCRITO	38	38 A 53
VCM	78	80 A 100
CHCM	29	30 A 36
RDW	12	11,5 A 15
LEUCÓCITOS	8.800	4.000 A 10.000
SEGMENTADOS	45	45 A 65%
BASTÕES	0	0 A 3%
EOSINÓFILOS	8	0 A 5%
MONOCITOS	2	0 A 3%
LINFÓCITOS	45	20 A 45%
PLAQUETAS	500.000	150.000 A 450.000

Hb: normal = ausência de anemia >> provável evolução para essa situação.

Hematócrito: normal (concentração normal no plasma).

↓ VCM: diminuído (células microcíticas).

↓ CHCM: diminuído (células hipocrômicas).

Anemia microcítica e hipocrômica: deficiência de ferro?

RDW: normal = ausência de Anisocitose.

Leucócitos: valor normal, mas EOSINOFILIA (↑ eosinófilos) = reação alérgica? Parasitose?

↑ Plaquetas: importante plaquetocitose/trombocitose.

Policitemia Vera

Neoplasia mieloproliferativa das células produtoras de sangue da medula óssea que resulta na superprodução de todos os tipos de células sanguíneas.

Resultado: ao Hemograma encontra-se situação de **pancitose** (tudo está muito elevado).

Leucemias

Alterações leucocitárias malignas: processos proliferativos de algumas linhagens de leucócitos.

Mielóide: afeta eritrócitos, plaquetas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos.

Linfoide: afeta linfócitos.

Leucemias

Mielóide

Linfoide

Aguda

Crônica

Aguda

Crônica

Células perderam a capacidade de se diferenciar

Acúmulo de Blastos (+20%)
[Leucocitose]

+Comum:
adultos +50 +60 anos

As células tumorais mantiveram sua capacidade de diferenciação

Presença do cromossomo Filadélfia (9/22)

Leucocitose progressiva

+Comum:
Homens +50 anos

Células perderam a capacidade de se diferenciar

Acúmulo de Blastos (+20%)
[Leucocitose]

+Comum:
crianças -10 anos
adultos +40 anos

As células tumorais mantiveram sua capacidade de diferenciação

Leucocitose às custas de Linfócitos (+5000)

+Comum:
Homens
Pessoas +60 +70 anos

Linfomas

Tratam-se de neoplasias linfoides de células maduras, que se proliferam de forma crônica na maioria das vezes.

Não Hodgkin de células B:

- MAIS COMUM.
- Sintomas B: febre por mais de 15 dias, sudorese noturna, emagrecimento maior que 10% em 06 meses; não intencional.
- Linfonodomegalia (indolor, endurecida, generalizada) & Hepatoesplenomegalia.

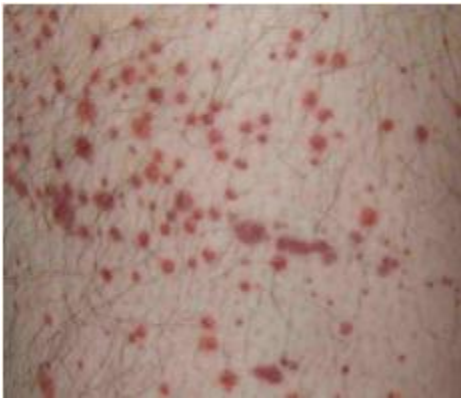
Hodgkin:

- MAIS RARO.
- Presença de células Reed Sternberg = diagnóstico.
- Sintomas B: febre por mais de 15 dias, sudorese noturna, emagrecimento maior que 10% em 06 meses; não intencional.
- Linfonodomegalia LOCALIZADA ou em cadeia.

Manifestações decorrentes de alteração da hemostasia

PÚRPURAS = Alteração de hemostasia primária (plaquetas deficientes ou em menor número) → Hemorragias de pele e mucosa.

Petéquias:



Equimoses:



COAGULOPATIAS = Alteração de hemostasia secundária → Hematomas + Hemorragias

TROMBOSE = Alteração de hemostasia terciária → TVP, DAOP.

- TVP: pernas quentes, edemaciadas, avermelhadas.
- DAOP: pernas frias, pálidas ou cianóticas.

SEMIOLOGIA APARELHO RESPIRATÓRIO

OBS: Examinar faces anterior e posterior do tórax em todas as fases do exame.

OBS: Paciente sentado numa cadeira comum (X) → Ir para a maca ou ficar de pé (✓).

Inspeção

Estática: OBSERVA-SE O TÓRAX DO PACIENTE.

1. Cumprimente o paciente.
2. Informe que suas mãos estão limpas.
3. Dê o comando para que o paciente se sente sobre a maca e retire a blusa (tórax SEMPRE desnudo).
4. Começar a observar o tórax.
 - Qual é o seu formato? Típico (Escoliótico, cifótico, de sapateiro, em barril...) ou ATÍPICO (normal).
 - Presença visível de abaulamentos, depressões, cicatrizes?
 - Simétrico?
5. Sempre comparar um HTX com o outro.

Exame normal: Tórax atípico. Simétrico. Ausência de depressões ou abaulamentos visíveis.

Dinâmica: OBSERVA-SE A RESPIRAÇÃO DO PACIENTE.

1. Tórax desnudo + higienização.
2. Qual o tipo de respiração? Toracoabdominal (+ comum em homens) ou Torácica (+ comum em mulheres)?
3. Uso de musculatura acessória? Tiragem?
4. Movimentos respiratórios regulares?
5. Qual o FR? Eupneico? Taquipneico? Bradipneico? Apneico?

Exame normal: Tipo de respiração X. Não há uso de musculatura acessória. Movimentos respiratórios regulares. Eupneico (entre 12-20 IRPM).

Palpação

Objetivo: perceber integridade, expansibilidade e FTV.

Integridade

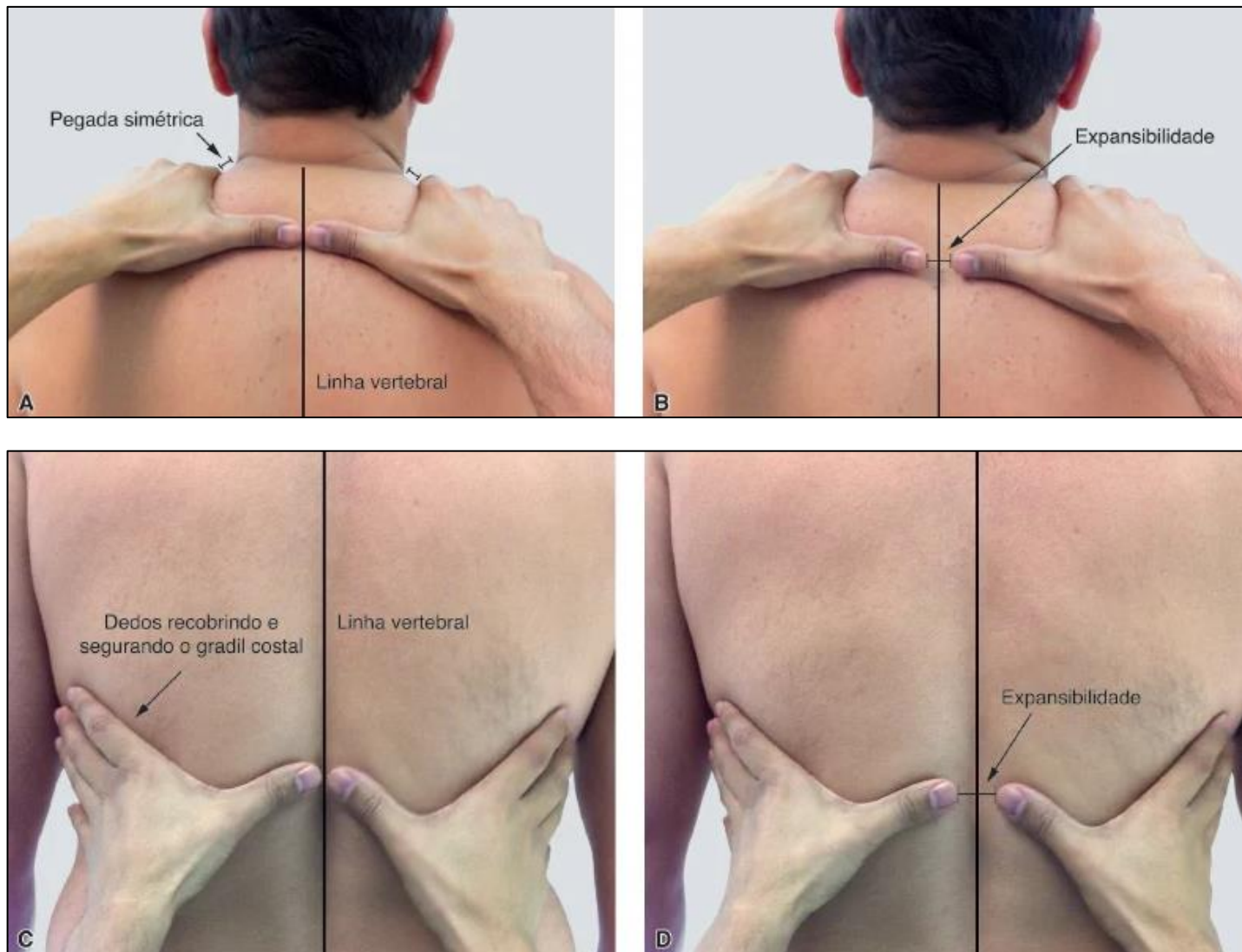
Mão espalmada sobre o tórax (ápice-base) percorrendo toda a região e percebendo se há: lesões, abaulamentos depressões, massas, calos ósseos...

Exame normal: integridade normal do tórax. Ausência de deformidades.

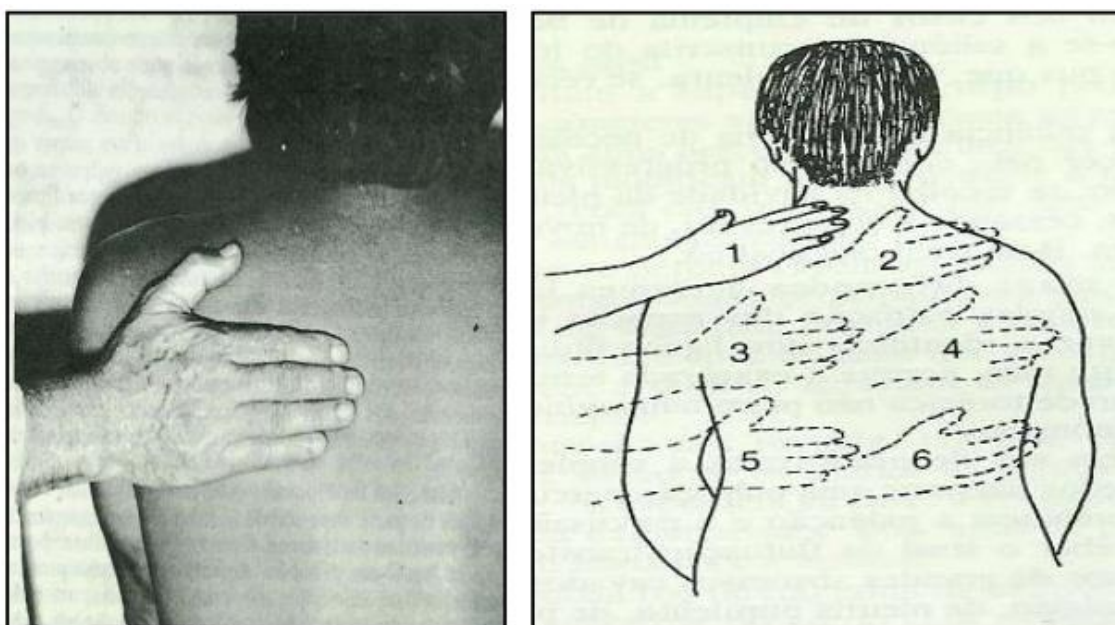
Expansibilidade

- Mão espalmada sobre o tórax (ápice-base) e polegares próximos.
- Comando: inspire e expire profundamente, por favor.
- Perceber movimentação dos dedos.

Exame normal: expansibilidade preservada bilateralmente. Simetria.



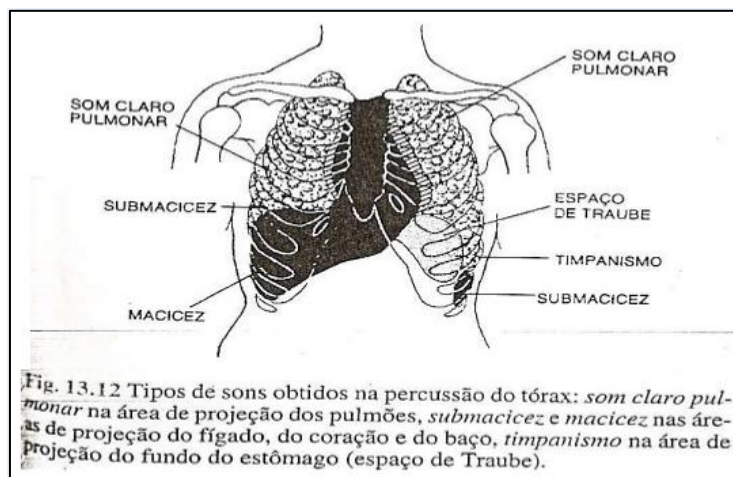
FTV



- Colocar a mão sobre as regiões do tórax.
- Comando: repita a palavra “33” a cada vez que eu trocar a posição das minhas mãos.
- Deslocar a mão espalmada por todo o tórax, comparando lados opostos (anterior, posterior, lateral) sentindo o frêmito.

Exame normal: FTV presente bilateralmente e simétrico.

Percussão



Técnica:

- Paciente com tórax desnudo + Higienização das mãos.
- Posicionar-se ao lado DIREITO do paciente.
- Dedo médio encostado no paciente, os outros discretamente elevados >>> movimentos dígitos-digitais.



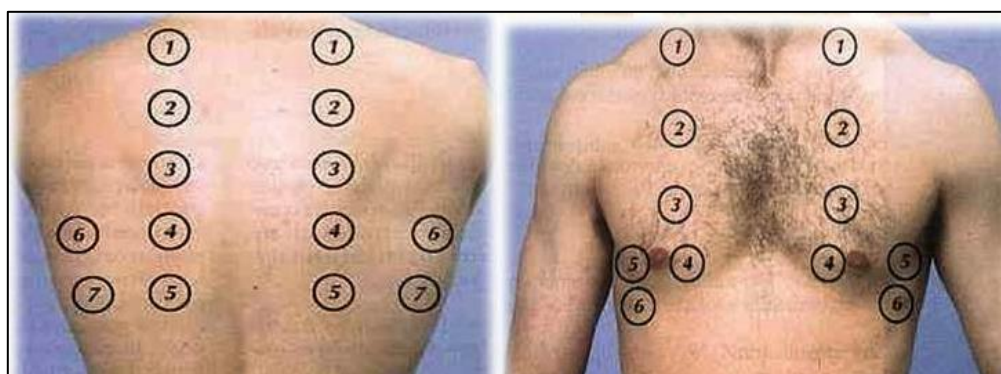
Exame normal DO AP. RESPIRATÓRIO: À percussão o paciente apresentou o som claro pulmonar.

OBS: "Faça a percussão do TÓRAX": pode-se acrescentar **macicez hepática e macicez cardíaca**, aos níveis do 5º e do 3º EIC respectivamente.

Ausculta

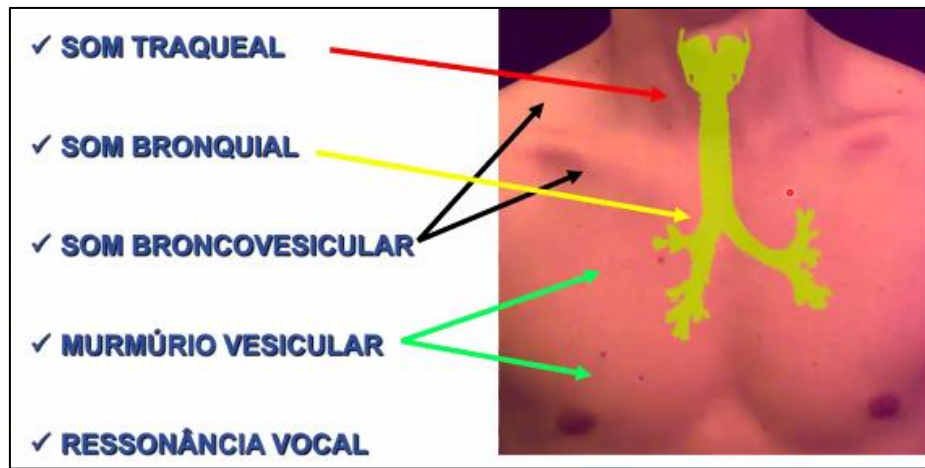
Comando: Senhor (a), vamos fazer assim: encha o peito respirando pelo nariz e solta o ar pela boca sempre que eu disser "de novo".

Focos: (auscultar pelo menos 6 focos anteriores e 6 focos posteriores).



Exame normal: À ausculta paciente apresentou murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios (MVF/SRA).

Sons normais



Ressonância Vocal (Ausculta da Voz)

O ideal é fazer uma pergunta ao paciente, da qual você não tem conhecimento da resposta:

- Quantos anos você tem?
- Qual o nome da sua mãe?
- Qual a cidade vizinha de Ipatinga?
- Também se utiliza o “33”

À medida que se faz a pergunta, “corre” com o estetoscópio pelo tórax, auscultando a voz.

Exame normal: Ressonância vocal ininteligível (voz não compreendida).

Síndromes Respiratórias

	Asma	Enfisema Pulmonar
Forma do tórax	NORMAL (casos muito graves: hiperinsuflado)	Hiperinsuflado (mais comum que na asma; mais típico).
Expansibilidade	NORMAL	↓
FTV	NORMAL ou ↓	↓
Percussão	NORMAL ou Hipersonoro	Hipersonoro
Ausculta	MV ↓ + Sibilos	MV ↓ + Roncos
Ressonância vocal	↓	↓

Obs: **Na Pneumonia:** ausculta com crepitações/estertores.

	Consolidação	Atelectasia	Derrame Pleural	Pneumotórax
Forma do tórax	NORMAL (só substituição)	Retração no HTX afetado	Normal ou Abaulado	Normal ou Abaulado
Expansibilidade	↓	↓	↓	↓
FTV	↑	↓	↓	↓
Percussão	Macicez	Macicez	Macicez	Hipertimpânico
Ausulta	Presença de crepitações MV ausente (substituído por som MAIS INTENSO = brônquico)	Abolida (pulmão colabado/sem ar)	↓ (MV diminuído ou abolido no HTX afetado)	↓ (MV diminuído ou abolido no HTX afetado)
Ressonância vocal	↑ Pectilóquio (som inteligível)	↓	↓	↓
Desvio de mediastino??		SIM IPSOLATERAL ao HTX afetado (puxa para o lado afetado)	SIM CONTRALATERAL ao HTX afetado (empurra para o lado normal)	SIM CONTRALATERAL ao HTX afetado (empurra para o lado normal)
Desvio de ictus??	NÃO			